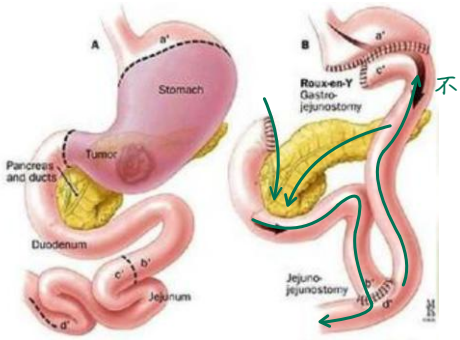
主要反流碱性物质,胃不能耐受

2.**碱性反流性胃炎**（多在术后 1-2 年）反流烧心 ┌内科学-胃食管反流病 └外科学-碱性反流性胃炎　但凡做胃和近端空肠的毕工式吻合的

①**反流**、**烧心**、呕吐物含胆汁、**呕吐后腹痛不缓解**、体重减轻、抑酸治疗无效 这种结构都决定容易碱性反流

②治疗：**胃-空肠 Roux-en-Y 术** 切除远端胃、缝合十二指肠残端旷置、切断远端空肠与残胃吻合,近端空肠与远端空肠吻合

VS 毕工式:胃和近端空肠吻合



不会往这个方向流

碱性反流性胃炎 晚期倾倒综合征

1 2 3 4 5→残胃癌

溃疡复发 早期倾倒综合征

3.溃疡复发、吻合口溃疡：多在术后 2-3 年

4.残胃癌：>5 年（威武）

切除壁细胞:盐酸、内因子缺乏→影响铁、VitB12吸收 脂肪排太快,没来得及消化

5.营养性并发症：巨幼贫、缺铁贫、体重减轻、脂肪泻、骨病 胃酸缺乏钙吸收↓而酸本身也有利于离子化钙形成

铁的主要来源是衰老红细胞而不是外界吸收过来 因此更不常见

↓慢性胰腺炎、胰腺癌(胰酶缺乏)　食物排空过快、长期消化液的丢失

七、特殊类型消化性溃疡 共性:药物治疗差、手术易复发

GU　DU

1.复合溃疡（胃溃疡合并十二指肠溃疡，II型胃溃疡）：胃酸分泌少量增加、癌变率很低

先有DU再有GU

2.高位溃疡（IV型胃溃疡）：与服用 NSAIDs 有关　离幽门远　VS 胃癌:好发于胃窦部,容易发生幽门梗阻

①多在胃底(胃酸壁细胞)、胃体(胃蛋白酶主细胞)的后壁（易穿透——背部痛），**不易幽门梗阻** VS 十二指肠溃疡慢性穿孔-背部痛

②与胃癌类似：中老年、症状不明显、直径>2cm、胃酸不高、贫血、体重↓

老年人对疼痛不敏感　I、IV型:一头一尾,胃酸正常/减少

好发于胃底和胃体:
①IV型胃溃疡
②A型胃炎
③应激性溃疡

3.巨大溃疡（直径>2cm）：多见于长期服用 NSAIDs 及老年人

能忍

4.幽门管溃疡（III型胃溃疡）三通管

①胃酸分泌少量增加

②症状最不典型 进食后马上痛

③最易幽门梗阻、易出血、易穿孔

I型胃溃疡:胃窦部
II型胃溃疡:胃溃疡+十二指肠溃疡
III型胃溃疡:幽门管溃疡
IV型胃溃疡:高位胃溃疡,胃底胃体

5.**十二指肠球后溃疡** 不是球部后壁　2 3

①在十二指肠 **2/降部、3/水平部：不易幽门梗阻** e.g 胰腺为腹膜后器官,十二指肠C型包绕

②典型节律性（夜间痛）十二指肠2、3部位于腹膜后(腹膜外位器官),故易向后穿透(慢性穿孔)

③易慢性穿孔（穿透——**背部痛**），可引起胰腺炎致**淀粉酶增高**，严重时可致梗阻性黄疸

④**最易出血** 血管在后面　腹膜后(胰腺炎、十二指肠球后溃疡)、十二指肠球部溃疡慢性穿孔

不容易发生幽门梗阻的消化性溃疡:高位溃疡、十二指肠球后溃疡

6.儿童期溃疡：多为脐周疼痛

全消化道可发病

7.难治性溃疡：克罗恩病、胃泌素瘤、放疗术后等所致

胃酸分泌显著↑→偏碱性的地方都可发生溃疡